SDD 91 Sujet n°1 (scénario)

Spécialité : ORL

Date : 22/10/2023
Auteur : RAVEL Anaïs
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023), Lucie-Lou (DES MAR)

Par défaut, tous les éléments doivent être demandés par le candidat.
Ce que tu peux dire spontanément est clairement indiqué.
Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

1) Informations détaillées :

- Vous êtes interne d'hépatologie, et vous passez un appel téléphonique auprès de l'interne d'avis de Chirurgie Maxillo-Faciale (incarné par le/la candidat.e) pour l'un de vos patients
- Le patient en question : Monsieur C, 63 ans, est hospitalisé en hépatologie dans le cadre de sa cirrhose et présente une lésion de langue inquiétante
- Rester professionnel, s'adapter au tutoiement/vouvoiement du candidat médecin (discussion d'interne à interne donc tutoiement possible)

Le/La candidat.e médecin doit analyser l'iconographie et interroger son confrère [vous] afin d'émettre son(ses) hypothèse(s) diagnostique(s).

Spontanément (phrase d'introduction) :
« Je t'appelle/vous appelle pour Monsieur C, un homme de 63 ans, hospitalisé chez nous. On a remarqué une lésion sur sa langue qui semble inquiétante et j'aimerais bien avoir ton/votre avis dessus. »

Si le candidat pose la question (ne répondre qu'à la question) :

- Descriptif du patient :
  - 1,75 m pour 95 kg
  - mariée, 2 enfants de 28 et 31 ans
  - fumeur, consommation estimée à 70 paquets-années
  - consommation d'alcool estimée à 2 ou 3 pintes de bières par jour + 2 ou 3 verres de vin au déjeuner et au diner + au moins un bon verre de Pontarlier par jour (d'après lui « La flotte c'est gerbant d't'façon ! »)
  - pas de notion de prise d'autres toxiques
  - traitements : ATORVASTATINE 20 mg + PROPANOLOL 40 mg
  - agriculteur
  - vit à la campagne dans le fin fond de la Haute-Saône
  - n'aime pas trop les médecins et les hôpitaux, n'a plus de médecin traitant

- Antécédents :

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon) et Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- cirrhose alcoolique suivie en hépatologie depuis des années
- aucun élément suspect de malignité au niveau hépatique en imagerie récente
- hypertension artérielle + hypercholestérolémie traitées
- aucun antécédent d'irradiation connu
- pas d'antécédent personnel ou familial de cancer
- dernier examen biologique montrant une perturbation du bilan hépatique et des carences en vitamines B1, B12, D et K

- Découverte de la lésion :
  - hospitalisation en hépatologie pour une biopsie du foie dans un contexte de cirrhose alcoolique
  - lésion aperçu par l'externe pendant l'examen clinique d'entrée du patient
  - aucune plainte spontanée de la part du patient

- Examen clinique :
  - aires ganglionnaires cervicales : adénopathies latéralisées à droite, dures, environ 1 cm de diamètre, fixes
  - hygiène bucco-dentaire moyenne, appareillage dentaire au niveau des molaires inférieures
  - haleine fétide
  - légère dysarthrie
  - lésion latérale :
    - saignement au contact
    - sensible à la palpation et gêne au quotidien
    - induration de la base de la lésion à la palpation
    - 3x4 cm avec 0,5 cm d'épaisseur
  - lésion blanche *(attention cette lésion ne sera pas forcément remarquée par le candidat médecin donc ne surtout pas la mentionner spontanément)* :
    - faces dorsale + latérales de la langue
    - souple
    - ne se détache pas au grattage
    - indolore
    - étendue, pas de dimensions précises

Images tirées de Le Courrier Du Dentiste

2) Consignes spécifiques :

Questions à poser au candidat médecin en cas de blanc dans la discussion :

- Si le candidat médecin n'a pas assez exploité l'iconographie, à partir de 5 minutes d'entretien : « Y a-t-il autre chose à tirer de la photo ? »

Pour considérer que la photo à été assez expliquée, l'étudiant.e doit dire à propos de la photo que :

- *Il y a une lésion à décrire comme :*
  - *Bourgeonnante*
  - *Ulcéré*
  - *Latéralisé à droite*
- *Et noter la présence de plaque/zone blanche/blanchâtre*

- Si le candidat médecin n'a pas encore émis d'hypothèse diagnostique, à partir de 6 minutes d'entretien : « Tu penses/Vous pensez que c'est inquiétant du coup ? »

Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon) et Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)